

33 - 04-douleurs thoraciques - Pr. L. Bendriss

Bonjour, aujourd'hui on va présenter le cours sur les douleurs thoraciques. Le plan que nous allons adopter est le suivant. On va avoir une analyse sémiologique à travers l'interrogatoire.

Nous allons d'abord essayer de chercher le terrain et les antécédents. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit autrefois, pas n'importe qui fait n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez une prédisposition pour relier la douleur à une telle étiologie.

On va analyser de manière très sémiologique cette douleur thoracique pour s'orienter par rapport à la cause. Et puis par la suite, après avoir analysé tout ceci, on va approcher les causes. Soit vous avez des causes cardiaques, soit des causes non cardiaques.

Et parmi les causes cardiaques, vous avez la cause la plus fréquente, c'est l'angine du poitrin qui est une douleur thoracique due à l'ischémie myocardique par une sténose d'une artère coronaire, si l'on veut être simple. Puis nous allons aussi voir les causes non cardiaques pour pouvoir poser le diagnostic différentiel. Alors les objectifs de ce cours, c'est de reconnaître les principales causes cardiaques de la douleur thoracique qui sont pratiquement quatre causes cardinales.

On va les voir tout à l'heure. Puis on va relever par rapport à chaque cause cardiaque, quels sont les caractéristiques sémiologiques de la douleur thoracique pour essayer d'approcher cette cause. Et puis on va essayer par la suite de poser le diagnostic différentiel.

La douleur thoracique, comme vous le savez, est un symptôme qui est subjectif parce qu'il est rapporté par le patient, donc difficilement quantifiable et vérifiable. Sachez qu'il est facilement trompeur, donc attention et prudence. Ça pourrait être une simple angoisse, un stress que le patient va ressentir au niveau du cœur et vous dire que j'ai mal au niveau du cœur, jusqu'à carrément la cause la plus grave qui est l'infarctus myocarde, qui est une nécrose myocardique secondaire à une occlusion de l'artère coronaire.

Donc ça va du plus simple vers le plus grave, donc attention, bien analyser la sémiologie de la douleur thoracique pour être prudent par rapport à des causes qui sont graves. Quand l'origine de la douleur thoracique est cardiovasculaire, je vous ai dit qu'il y a 4 étiologies cardinales qu'il faut mémoriser par cœur. On va les résumer dans le mot PIED.

Alors P, c'est la péricardite aiguë, c'est l'inflammation du péricarde qui est l'enveloppe ou la tunique externe du cœur. I, c'est l'insuffisance coronaire, ça veut dire que vous avez un problème de sténose coronarienne qui a engendré une douleur thoracique par une ischémie myocardique. Ça va de l'angor stable ou moins grave jusqu'à l'infarctus myocarde, qui est une urgence vitale.

Et puis E, c'est l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est un embolus fibrino-criurique qui est issu d'une thrombose au niveau d'une veine périphérique et qui va avoir lieu soit au niveau du tronc de l'artère pulmonaire, soit les branches des artères pulmonaires ou les branches

carrément périphériques. Et puis D, c'est la dissection aortique qui serait due à une déchirure de l'aorte et qui va créer deux chenons, un chenal qui va circuler et un faux chenal.

Je commence par l'interrogatoire pour essayer d'analyser justement ces douleurs thoraciques pour pouvoir raisonner et approcher la cause. Alors on commence toujours par le terrain et les antécédents parce que pour essayer de chercher la prédisposition à faire telle ou telle étiologie. Alors quand je vais chercher dans le terrain, d'abord je vais évaluer les facteurs de risque cardiovasculaires primo-athéromateux.

Athéromaton, on en a déjà parlé l'autre fois, c'est tous les facteurs de risque qui prédisposent à déposer une plaque d'athérome sur une artère. Et quand vous avez une plaque qui va se déposer sur une artère, ça va entraîner une sténose et plus la sténose va évoluer et devenir significative, ça va répercuter sur l'irrigation de l'organe au final. Et quand il s'agit par exemple d'une artère coronaire, vous aurez l'angore, l'angine de poitrine, jusqu'à l'infarctus du myocarde.

Donc c'est des facteurs de risque qui vont prédisposer, athéromateux à l'insuffisance coronarienne. Et on en a déjà parlé dans le cours précédent, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, l'âge, le sexe masculin, la sédentarité et l'obésité. Deuxième terrain, c'est les facteurs de risque thromboemboliques veineux qui vont prédisposer à l'embolie pulmonaire comme deuxième étiologie.

Alors c'est des facteurs de risque qui vont prédisposer à avoir un thrombus veineux. Et ce thrombus veineux va migrer au niveau de la circulation pulmonaire, entraîner une embolie pulmonaire. Et parmi les facteurs, grossièrement, on va le voir plus tard, qui vont entraîner la formation d'un thrombus veineux, c'est la stase.

Quand un patient vient d'être opéré et il est alité de plus de trois jours, donc j'aurai une stase veineuse qui va prédisposer à avoir la thrombose veineuse profonde. Puis comme troisième terrain, c'est le marfan et l'hypertension artérielle qui vont prédisposer à la troisième étiologie qui est la dissection aortique. Le marfan c'est une pathologie qui est due à une déficience en tissu élastique, notamment au niveau de l'aorte.

Et quand vous avez une aorte qui n'est pas élastique, elle n'est pas du tout COMPLIANTE, et du coup j'aurai une aorte qui est facilement prédisposée à être déchirée. Donc le marfan prédispose à la dissection aortique et l'hypertension artérielle qui est la pression qui va gicler sur les parois risque de faire aussi déchirer l'aorte et avoir la dissection aortique. Puis comme quatrième terrain, alors ça c'est des facteurs qui prédisposent à avoir la péricardite, c'est-à-dire l'inflammation du péricarde, soit par un épisode d'infection, n'importe quelle infection peut entraîner aussi une infection du péricarde et j'aurai une inflammation.

La tuberculose aussi, la néoplasie, que ce soit un cancer primitif ou secondaire, peut m'épauler au niveau du péricarde. L'insuffisance rénale chronique par l'hyperhydratation, je peux avoir un épanchement péricardique. Le rhumatisme articulaire aigu, qui est une maladie qui

va toucher les trois tuniques cardiaques, l'endocarde, le myocarde et le péricarde.

Et puis les maladies de système, où c'est des maladies où vous aurez une atteinte cardiaque qui va faire un petit peu l'un des panocliniques de ces maladies de système, notamment la péricardite. Alors les facteurs de risque, cardiovasculaire, athéromate, on en a déjà parlé dans le cours précédent, qui prédispose à l'insuffisance coronarienne. Les facteurs de risque, thromboembolique veineux, qui va prédisposer à avoir la thrombose veineuse profonde et puis l'embolie pulmonaire, c'est ce qu'on appelle la maladie thromboembolique veineuse.

Alors par rapport à la thrombose veineuse, vous avez ce qu'on appelle une triade de Virchow, vous avez trois points pour avoir la prédisposition de former une thrombose veineuse. Vous avez la stase veineuse, donc un sang qui est stagnant, puis vous avez par la suite l'hypercoagulabilité, vous avez des situations cliniques, vous aurez une augmentation des facteurs de coagulation et puis vous aurez comme troisième point, c'est la lésion veineuse, qu'on peut léser une veine, par exemple en cas de notre passage au cours d'une chirurgie. Alors si je somme le maximum de ces facteurs-là, j'augmente la probabilité d'avoir une thrombose veineuse.

Alors comme facteur de risque permanent qui sont toujours là et qui nous prédispose à avoir la maladie thromboembolique veineuse, vous avez les anomalies de la coagulation, une paralysie d'un membre, donc vous aurez la stase veineuse tout le temps, un antécédent personnel de maladie thromboembolique veineuse parce que vous avez toujours le risque de récurrence, un cancer ou un antécédent de cancer où vous avez une hypercoagulabilité et la surcharge pondérale. Puis vous avez les facteurs temporaires ou transitoires mais qui sont majeurs de maladie thromboembolique veineuse, l'immobilisation plâtrée, donc quand vous posez un plâtre, vous avez bien évidemment la stase veineuse, un allaitement de plus de trois jours et une chirurgie récente qui prédispose à la stase et à l'hypercoagulabilité. Puis vous avez des facteurs de risque qui sont temporaires ou provisoires mais qui sont mineurs, pas assez pourvoyeurs de manière certaine de maladie thromboembolique veineuse, voyages par avion pour des longues distances, même chose pour un bus de plus de six heures.

N'oubliez pas, la situation de l'accouchement prédispose à la maladie thromboembolique veineuse, donc toujours les patients qui viennent d'être opérés avec l'allaitement, on leur prescrit des anticoagulants de manière prophylactique et puis la contraception orale prédispose aussi à la maladie thromboembolique veineuse. Alors, après avoir analysé le terrain, on va passer à l'analyse de manière très sémiologique de la douleur thoracique qui va être toujours stéréotypée de cette manière à chaque fois que vous avez une douleur thoracique. Vous allez préciser d'abord le type, est-ce qu'elle est constrictive, est-ce qu'elle a un type de brûlure, est-ce qu'elle est en coup de poignard, l'intensité, de faible intensité jusqu'à une intensité importante, le siège, est-ce qu'elle est rétrosternale, est-ce qu'elle est baso-thoracique, précordiale, les irradiations, est-ce qu'elle va irradier cette douleur au niveau de la mâchoire, le dos, le ventre supérieur, les signes qui vont accompagner la douleur, la dyspnée, la toux, ce que vous voulez, le mode de

déclenchement, l'effort spontané, la durée, ça va de quelques minutes jusqu'à plusieurs heures, et puis les facteurs de sédation ou d'aggravation, soit les facteurs qui vont faire céder la douleur ou aggraver ou augmenter son intensité.

Alors voici un tableau récapitulatif des principales causes cardiaques avec une analyse sémiologique de la douleur thoracique en fonction de chaque cause. Alors par rapport à la péricardie, le siège est généralement précordial, l'intensité est variable, elle est surtout active de coups de poignet, mais surtout active de brûlure, sans aucune irradiation, de survenue spontanée, mais les choses essentielles, c'est que cette douleur péricardique est augmentée par l'inspiration forcée et diminue par la position, par l'antéflexion ou la position penchée en avant. La douleur thoracique de régime coronarien, vous aurez plusieurs tableaux cliniques par rapport à si vous avez un engorgement ou un infarctus myocardique, mais vous avez des caractéristiques en commun.

C'est une douleur thoracique qui est rétrosternale, c'est-à-dire derrière l'esternum. Alors l'intensité est variable, soit qu'elle est simple, soit qu'elle est angoissante quand vous avez un infarctus myocardique. Elle est à type de constrictive, donc vous avez la sensation si vous serrez votre thorax, une pesanteur comme si vous aviez un objet lourd sur le thorax.

L'irradiation, c'est généralement la mâchoire inférieure, l'épaule et le bras gauche. Elle survient généralement à l'effort et cède à l'arrêt de l'effort. La durée va de quelques minutes pour l'engorgement jusqu'à une durée prolongée pour l'infarctus myocardique.

Comme troisième cause, vous avez l'embolie pulmonaire. C'est une douleur thoracique qui est basique thoracique à type de coup de poignet ou de poing sans aucune irradiation, de survenue spontanée, mais qui peut varier avec la respiration et rien ne la fait diminuer et de durée variable. La dissection aortique est une douleur thoracique rétro-sternale.

Elle est violente à type de déchirure. Vous allez sentir comme si la horte se déchire. Irradiation descendante, ça va suivre le trajet de la horte derrière ce qu'on appelle dorsale, de survenue spontanée et rien ne fait diminuer cette douleur thoracique.

Alors, si je rentre dans la douleur thoracique d'origine coronarienne, donc l'angine de poitrine, qui est la douleur thoracique qui est due à l'ischémie myocardique, pourquoi j'aurais cette ischémie? Parce que vous avez un déséquilibre entre les apports et les besoins du myocarde. Les apports sont assurés par la circulation coronaire et les besoins myocardiques, c'est les besoins en oxygène du myocarde, surtout dans les situations d'effort. Et si vous avez un cœur qui est soumis à un effort avec une circulation coronaire qui ne le suit pas à cause d'une sténose, je pourrais avoir un déséquilibre et ça va entraîner la douleur thoracique.

Et comme je vous l'ai dit, l'athérosclérose ou les plaques d'athérose sont la cause principale dans 90% des cas de cette angine de poitrine. Il faut bien évidemment chercher les facteurs de risque cardiovasculaire athéromateux qui prédisposent à cette angine de poitrine. Vous avez divers

tableaux, ça va de l'engueur d'effort stable jusqu'à l'engueur instable et l'infarctus du myocarde.

Pour parler d'un engueur d'effort stable, je devrais avoir un seuil ischémique stable, c'est-à-dire que j'aurai la douleur thoracique toujours pour le même niveau d'effort qui ne doit pas changer. Parce que quand le niveau d'effort va changer, je rentre dans l'instabilité et c'est une douleur thoracique qui est rétrosternale, de type constrictive, qui survient à l'effort et qui s'aide à l'arrêt de l'effort de durée brève, moins de 15 minutes. Elle est atypique quand vous avez toute l'asthmologie, c'est-à-dire qu'il irradie au niveau de la mâchoire, le membre supérieur gauche qui s'aide à l'arrêt de l'effort.

Elle serait atypique si vous avez un critère qui va manquer, par exemple si quelqu'un vous rapporte une douleur thoracique qui survient à l'effort mais qui n'est pas rétrosternale, mais plutôt située au niveau du membre supérieur gauche. Donc c'est une douleur atypique. Ou si vous avez des manifestations autres qui s'y associent à cette douleur, notamment des manifestations digestives ou respiratoires.

Alors, l'angore instable, quand je dis instable, c'est quand on commence à avoir une instabilité, ça veut dire quoi? J'avais une sténose coronarienne mais soudainement j'ai une rupture de cette plaque et vous avez la cascade de coagulation qui va suivre, donc j'aurai un thrombus fibrinocriurique qui va compléter cette sténose mais en cas d'angore instable, c'est une subocclusion, ou si vous voulez dire une occlusion incomplète de l'artère, c'est la raison pour laquelle on n'est pas arrivé encore dans l'infarctus mucale. Alors, vous avez plusieurs tableaux pour l'angore. Un angore de nouveau, nouveau ça veut dire on vient d'avoir ces douleurs thoraciques avec un recul de moins de deux mois, ça veut dire c'est tout récent.

Un angore aggravé, ou ce qu'on appelle crescendo, ça veut dire vous avez un seuil ischémé, un seuil ischémé, ça veut dire le niveau d'effort qui a changé pour la douleur thoracique, ça veut dire quelqu'un qui vous disait je faisais la douleur thoracique à deux étages, et je commence à avoir la douleur thoracique à la montée d'un seul étage, donc il y avait un abaissement du seuil ischémique, donc je suis rentré dans l'instabilité de ce qu'on appelle un angore aggravé. Puis vous avez l'angore spontanée, qui ne survient pas cette fois-ci à l'effort mais au repos, donc vous avez c'est encore plus grave. Puis un angore précoce, post-infarctus mucale, ou revascular, ça veut dire qu'on vient de faire un infarctus mucale tout récent et puis nous avons un angore précoce dans le mois qui suit, c'est une instabilité toujours, et un angore de prence métale, c'est un angore qui survient surtout la nuit, surtout vers les premières heures du matin, donc 2h, 3h, 4h du matin, et qui se réduit plutôt à un spasme d'une artère coronaire, c'est quoi un spasme? C'est une artère qui va avoir une vasoconstriction extrême jusqu'à une fermeture de l'artère, et ça va mimer un petit peu, c'est comme si vous aviez une occlusion de l'artère, mais cette fois-ci par son spasme.

Elle est complètement spasmée, c'est-à-dire complètement fermée juste un petit peu par la vasoconstriction, et ça ne dure pas très longtemps, donc soudainement, quand le spasme va être

relâché, l'artère va être libérée, et la douleur va céder. Alors l'infarctus mucale, c'est la forme extrême, c'est une ischémie irréversible du mucale, parce qu'on avait une occlusion totale d'une artère, qui dit occlusion totale, vous aurez une nécrose, une myocarde adjacente, donc c'est une douleur thoracique qui est introthermale, qui est constrictive, qui est très intense, avec sensation de mort imminente, on sent que la mort est proche, et elle est spontanée, et surtout, elle est prolongée, elle dure plus de 20 minutes, et elle est résistante aux dérives inutiles, les dérives inutiles c'est des vasodilatateurs qui entraînent une vasodilatation des artères coronaires, dans l'endorstable, il n'est ni trop sensible, par contre l'infarctus mucale il n'est ni trop résistant, et ce qui caractérise l'infarctus mucale, c'est que vous avez tout un cortège fonctionnel qui l'accompagne, ça veut dire des signes d'hyperactivité sympathiques, à savoir les sueurs, à savoir l'angoisse, à savoir l'attaque icardie, la peur, donc c'est tout un cortège fonctionnel qui va englober le tableau d'infarctus mucale. Alors, les autres origines cardiaques de la douleur thoracique, on avait parlé un petit peu de l'insuffisance coronaire avec les différents tableaux, endorstable, instable et infarctus mucale, puis je vous ai parlé de l'emboîté pulmonaire, donc il faut chercher le terrain qui prédispose notamment les fartes de risques thromboboliques véneux, comme on avait vu tout à l'heure, et puis c'est une douleur thoracique, généralement où vous avez une association avec la dyspnée et une plaque icardie, la dissection aortique c'est surtout le terrain d'hypertension artérielle et de la maladie de Marfan, et puis comme quatrième cause, la péricardite, donc il faut chercher si le patient vient de faire par exemple un épisode d'infection tout récent, une grippe, n'importe quelle infection qui vient d'être toute récente dans ses antécédents, un comptage tuberculeux de la famille, une néoplasie, s'il est suivi pour l'insuffisance rénachronique, s'il est connu suivi pour une maladie système, tout ceci va vous orienter vers la péricardite et dans cette péricardite vous aurez la douleur thoracique associée à une dyspnée et fébriqueux ou fièvre.

Alors, les autres origines non cardiales, c'est-à-dire on va essayer de poser le diagnostic différentiel, donc c'est tout ce qui est trachée, branche et plèvre, donc tracu, branché, pneu motoraxe et pneurysis, ça va causer des douleurs thoraciques, tout ce qui se rapporte à la cage thoracique ou à la paroi, donc toutes les atteintes costales, musculaires, puis les arthroses, n'oubliez pas les arthroses, les articulations costosternales, et puis le douleur nerveuse, ça va avoir la névralgie intercostale, par exemple dans le zona, la névralgie cervico-braquiale qui est assez fréquente comme diagnostic, et puis n'oubliez pas les causes digestives qui peuvent avoir une irradiation au niveau thoracique, notamment un ulcère, un reflux, une pancréatite aiguë peut avoir comme signe, si vous voulez dire, révélateur de douleur thoracique, et enfin, enfin, quand tout ceci en a éliminé toutes les causes organiques, l'angoisse ou la peur reste un diagnostic d'élimination, et je vous remercie.